Vstupní pneumoonkologická zpráva pro MDT

Pacientka, 66 let · fiktivní data · datum zprávy 16. 10. 2026 · odesílající: pneumologická ambulance (fiktivní pracoviště)

Mock-up pro testovací import do MDT Copilot. Neobsahuje skutečné osobní údaje.

IDENTIFIKACE A SOUČASNÝ STAV

Pacientka, 66 let, narozena v roce 1960, žena. Výška 164 cm, hmotnost 78 kg (BMI 29,0), před 3 měsíci 82 kg. Celkový stav středně nemocná, soběstačná, klinicky stabilní.

DIAGNÓZA A STAGING

MKN-10: C34.1 – zhoubný novotvar horního laloku průdušky nebo plíce; vpravo, segment S2.

Klinické stadium dle TNM 8. vydání: cT2a cN2 cM0, stadium IIIA. TNM bylo stanoveno 8. 10. 2026 (PET/CT, EBUS-TBNA, MR mozku).

Histologie: invazivní nemucinózní adenokarcinom, převážně acinární, G2; TTF-1 pozitivní, p40 negativní. EGFR bez mutace, ALK negativní, KRAS G12C, PD-L1 TPS 40 %.

Ostatní diagnózy: CHOPN GOLD 2 (J44.9), ICHS po NSTEMI a PCI 2019 (I25.2), arteriální hypertenze (I10), diabetes mellitus 2. typu (E11.2), chronické onemocnění ledvin G3a (N18.3), dyslipidemie (E78.5).

FUNKČNÍ STAV

ECOG 1 – hodnoceno lékařem dne 16. 10. 2026. Pacientka je soběstačná, omezena jen v namáhavé činnosti (dušnost do schodů); sama svůj stav hodnotí stejně.

NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ

Od června 2026 dráždivý suchý kašel, od července 2026 dvakrát drobné žilkování krve ve sputu, progrese námahové dušnosti (nyní mMRC 2) a úbytek hmotnosti 4 kg za 3 měsíce. Praktický lékař indikoval RTG hrudníku (18. 8. 2026) se zastíněním v pravém horním plicním poli. CT hrudníku s kontrastem (2. 9. 2026): spikulovaný tumor pravého horního laloku 38 × 30 mm, zvětšené uzliny 4R a 10R. Bronchoskopicky (15. 9. 2026) tumor v ústí B2 vpravo, histologicky adenokarcinom (22. 9. 2026). Došetřena PET/CT, EBUS-TBNA, MR mozku, funkční vyšetření plic a kardiologie k posouzení operability.

ANAMNÉZA

Rodinná anamnéza: otec zemřel v 72 letech na karcinom plic (kuřák), matka diabetes mellitus 2. typu a ICHS. Sourozenci zdrávi.

Osobní anamnéza:

- CHOPN GOLD 2, skupina B, sledována v plicní ambulanci od roku 2019; poslední exacerbace v lednu 2026 (ambulantně, antibiotika a kortikoidy), dosud bez hospitalizace.
- ICHS: NSTEMI v březnu 2019, PCI s implantací DES do RIA; nyní bez anginózních obtíží, CCS I.
- Arteriální hypertenze, na terapii kompenzovaná.
- Diabetes mellitus 2. typu na perorálních antidiabeticích, s počínající diabetickou nefropatií.
- Chronické onemocnění ledvin G3a A1.
- Dyslipidemie, nadváha.
- Operace: hysterektomie 2005 (myomy), laparoskopická cholecystektomie 2012. Úrazy neudává.

Gynekologická anamnéza: 2 porody, menopauza v 51 letech, hormonální substituci neužívala. Mamografie 2025 bez patologie.

Farmakologická anamnéza: kyselina acetylsalicylová 100 mg 1-0-0, atorvastatin 40 mg 0-0-1, bisoprolol 5 mg 1-0-0, perindopril 5 mg 1-0-0, metformin 1000 mg 1-0-1, sitagliptin 100 mg 1-0-0, tiotropium/olodaterol 2,5/2,5 µg 2 vdechy 1× denně, salbutamol 100 µg při dušnosti.

Alergie: penicilin (exantém, 2001).

Abúzus: bývalá kuřačka, 20 cigaret denně 40 let (40 balíčkoroků), nekouří od března 2024. Alkohol příležitostně, drogy neguje.

Sociální anamnéza: vdova, bydlí s dcerou v rodinném domě (schody do patra), důchodkyně, dříve účetní, bez profesní expozice. Soběstačná, nakupuje sama, delší chůzi omezuje dušnost.

SUBJEKTIVNĚ

Cítí se unavená, hlavně odpoledne. Kašel převážně suchý, ráno s malým množstvím bělavého sputa, poslední žilkování krve před 3 týdny. Dušnost při chůzi do schodů, do patra musí jednou zastavit; po rovině ujde asi 500 m. Chuť k jídlu mírně snížená. Bolesti na hrudi, stenokardie, teploty, noční pocení, bolesti kostí, bolesti hlavy, neurologické obtíže a otoky dolních končetin neguje.

OBJEKTIVNĚ

Vitální funkce: TK 146/84 mmHg, P 86/min pravidelný, SpO2 93 % bez kyslíku, DF 18/min, TT 36,6 °C.

Celkově: středně nemocná, lucidní, orientovaná, spolupracuje, v klidu eupnoická, při svlékání lehce dušná. Kůže a sliznice bez ikteru a cyanózy, hydratace přiměřená.

Hlava a krk: zornice izokorické, jazyk vlhký, náplň krčních žil nezvýšená, štítná žláza nezvětšená, krční a supraklavikulární uzliny nehmatné.

Hrudník: symetrický, dýchání sklípkové, vpravo nahoře oslabené, difuzně prodloužené exspirium, ojedinělé pískoty, bez chrůpků. Srdeční akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestu.

Břicho: měkké, prohmatné, nebolestivé, játra a slezina nezvětšené, jizvy po operacích klidné.

Končetiny: bez otoků, bez známek flebotrombózy, periferní pulzace hmatné, bez paličkovitých prstů. Orientačně neurologicky bez lateralizace.

LABORATOŘ

Odběr 13. 10. 2026.

Parametr	Hodnota	Jednotka	Referenční rozmezí
Leukocyty	9,1	10^9/l	4,0–10,0
Neutrofily absolutní	6,2	10^9/l	2,0–7,0
Hemoglobin	121	g/l	120–160
Trombocyty	356	10^9/l	150–400
Sodík	137	mmol/l	136–145
Draslík	4,6	mmol/l	3,5–5,1
Kreatinin	102	µmol/l	44–80
eGFR (CKD-EPI)	0,85	ml/s/1,73 m²	> 1,50
Urea	7,4	mmol/l	2,8–8,0
Bilirubin celkový	9	µmol/l	2–17

ALT	0,41	µkat/l	0,10–0,58
AST	0,46	µkat/l	0,10–0,58
GMT	0,72	µkat/l	0,10–0,63
ALP	1,42	µkat/l	0,58–1,74
LDH	4,1	µkat/l	2,25–3,75
Albumin	36	g/l	35–52
CRP	14	mg/l	0–5
Glukóza	8,1	mmol/l	3,9–5,6
HbA1c	57	mmol/mol	20–42
NT-proBNP	386	ng/l	0–125
INR	1,04	–	0,80–1,20
CEA	7,9	µg/l	0–5,0
CYFRA 21-1	4,6	µg/l	0–3,3
NSE	13	µg/l	0–16,3

Arteriální krevní plyny (1. 10. 2026, vzduch): pH 7,43, pO2 8,9 kPa, pCO2 5,2 kPa, SaO2 93 %.

SPIROMETRIE A FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC

Bodypletysmografie, spirometrie a difuzní kapacita, 1. 10. 2026.

Parametr	Naměřeno	% náležité hodnoty
FVC	2,61 l	88 %
FEV1	1,49 l	62 %
FEV1/FVC	57 %	–
TLC	5,32 l	109 %
RV	2,74 l	131 %
DLCO	3,9 mmol/min/kPa	52 %
KCO	0,98 mmol/min/kPa/l	63 %

Bronchodilatační test (salbutamol 400 µg): FEV1 +90 ml (+6 %), negativní.

Spiroergometrie (12. 10. 2026): VO2max 13,9 ml/kg/min (62 % náležité hodnoty), anaerobní práh 9,8 ml/kg/min, maximální zátěž 70 W, RER 1,08. Ukončeno pro dušnost a únavu dolních končetin, pokles SpO2 z 94 % na 89 %, EKG bez ischemických změn a arytmií.

Závěr funkčního vyšetření: středně těžká obstrukční porucha ventilace bez významné reverzibility, plicní hyperinflace, středně těžce snížená difuzní kapacita, mírná hypoxemie. Předpokládané pooperační hodnoty pro lobektomii pravého horního laloku (3 z 19 segmentů): ppoFEV1 52 %, ppoDLCO 44 %. Podle algoritmu ERS/ESTS zvýšené riziko; lobektomie hraničně možná, pneumonektomie nebo bilobektomie s vysokým rizikem.

KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Echokardiografie (9. 10. 2026): levá komora nedilatovaná, EF LK 50 %, hypokineze bazálního segmentu spodní stěny, diastolická dysfunkce I. stupně, chlopně bez hemodynamicky významné vady, odhad systolického tlaku v plicnici 32 mmHg.

Kardiologické konzilium (13. 10. 2026): stabilní ICHS, CCS I, bez známek ischemie při spiroergometrii, bez indikace k předoperační koronarografii. ThRCRI 1,5 bodu (třída B). Kyselinu acetylsalicylovou ponechat perioperačně. Riziko hrudního výkonu z kardiologického hlediska zvýšené, nikoli kontraindikující.

BRONCHOSKOPIE

Flexibilní bronchoskopie (15. 9. 2026) v lokální anestezii a analgosedaci: hlasivky symetricky pohyblivé, trachea volná, karina ostrá a štíhlá. Vpravo pravý hlavní a intermediární bronchus volné, horní lobární bronchus průchodný; ústí B2 zúžené asi o 60 % exofytickou, křehkou, při doteku krvácející nádorovou hmotou, okolní sliznice zarudlá, infiltrace nepřesahuje do horního lobárního bronchu. Vlevo bez patologického nálezu. Odběry: klešťová biopsie 6×, kartáčková cytologie, bronchiální výplach na cytologii a mikrobiologii. Bez komplikací, krvácení po biopsii zastaveno lokálně.

EBUS-TBNA (6. 10. 2026) v analgosedaci: stanice 4R 16 × 12 mm, 3 vpichy, ROSE pozitivní; stanice 7 9 mm, 3 vpichy; stanice 10R 11 mm, 2 vpichy; stanice 4L 6 mm, nepunktována. Bez komplikací.

CYTOLOGIE

Kartáčková cytologie a bronchiální výplach z B2 vpravo (15. 9. 2026): skupiny atypických epiteliálních buněk s jaderným pleomorfismem, nález suspektní z nemalobuněčného karcinomu. Mikrobiologie výplachu: běžná orofaryngeální flóra, mikroskopie i PCR na M. tuberculosis negativní.

EBUS-TBNA (výsledek 8. 10. 2026): stanice 4R pozitivní, metastáza adenokarcinomu, imunocytochemicky TTF-1 pozitivní; stanice 7 negativní, reprezentativní lymfoidní populace bez nádorových buněk; stanice 10R pozitivní, metastáza adenokarcinomu.

PET/CT A ZOBRAZENÍ

PET/CT s 18F-FDG (29. 9. 2026): v pravém horním laloku (S2) spikulované ložisko 38 × 31 × 29 mm, SUVmax 12,6, bez propagace k viscerální pleuře a hrudní stěně, od kariny více než 2 cm. Uzliny: 4R 16 × 12 mm, SUVmax 7,4; 10R 11 mm, SUVmax 4,9; subkarinální (7) 9 mm, SUVmax 2,3, nespecifické. Kontralaterální mediastinální, hilové a supraklavikulární uzliny bez zvýšené akumulace. Játra, nadledviny a skelet bez metabolicky aktivních ložisek. Centrilobulární emfyzém horních laloků. Závěr: metabolicky aktivní tumor pravého horního laloku s postižením ipsilaterálních hilových a mediastinálních uzlin, bez známek vzdálené diseminace.

MR mozku s kontrastem (7. 10. 2026): bez ložiskových změn, bez známek metastáz; drobné vaskulární gliózy.

HISTOLOGIE

Bioptické vyšetření č. B-2026/18734 (odběr 15. 9. 2026, výsledek 22. 9. 2026), bronchiální biopsie z ústí B2 vpravo: infiltrace sliznice invazivním nemucinózním adenokarcinomem, převážně acinární růstový vzor (asi 70 %), dále lepidický (15 %) a solidní (15 %) vzor; grade 2 dle IASLC (orientačně v bioptickém vzorku). Lymfovaskulární invaze ve vzorku nezastižena.

Imunohistochemie: TTF-1 pozitivní, napsin A pozitivní, CK7 pozitivní, p40 negativní, CK5/6 negativní, Ki-67 asi 30 %. Podíl nádorových buněk ve vzorku asi 40 %, materiál vhodný k prediktivnímu vyšetření.

BIOMARKERY

Prediktivní vyšetření z bioptického vzorku (výsledek 9. 10. 2026; NGS panel DNA a RNA, imunohistochemie):

- EGFR: bez mutace (wild-type).

- ALK: přestavba neprokázána (IHC klon D5F3 negativní, NGS negativní).
- ROS1: fúze neprokázána.
- KRAS: mutace p.G12C (c.34G>T), VAF 21 %.
- BRAF V600E: neprokázána.
- MET exon 14 skipping: neprokázán. RET a NTRK: fúze neprokázány.
- PD-L1 (klon 22C3): TPS 40 %.

ZÁVĚR

66letá pacientka s nově diagnostikovaným adenokarcinomem pravého horního laloku, klinicky stadium IIIA (N2 v jedné mediastinální stanici 4R, N1 10R), bez vzdálených metastáz, s hraničními komorbiditami pro resekční výkon.

Relevantní komorbidity a současný stav: CHOPN GOLD 2 (FEV1 62 %, DLCO 52 %, ppoFEV1 52 %, ppoDLCO 44 %, VO2max 13,9 ml/kg/min, SpO2 93 %), ICHS po NSTEMI a PCI 2019 (EF LK 50 %, ThRCRI 1,5), arteriální hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, chronické onemocnění ledvin G3a (eGFR 0,85 ml/s/1,73 m²). Středně nemocná, úbytek hmotnosti 4 kg za 3 měsíce.

Předchozí onkologická léčba: dosud žádná protinádorová léčba.

Preference a omezení pacienta: pacientka je informována o diagnóze, přeje si léčbu s kurativním záměrem, operaci nevylučuje, obává se trvalé dechové invalidity. Doprava na léčbu zajištěna dcerou. Alergie na penicilin.

OTÁZKA PRO MDT

Otázka pro MDT: adenokarcinom pravého horního laloku cT2a cN2 cM0, stadium IIIA (N2 jedna stanice 4R), EGFR a ALK negativní, KRAS G12C, PD-L1 TPS 40 %, s hraniční funkční operabilitou (ppoFEV1 52 %, ppoDLCO 44 %, VO2max 13,9 ml/kg/min, ICHS, CKD G3a). Je pacientka kandidátkou lobektomie po neoadjuvantní chemoimunoterapii, nebo je vhodnější definitivní konkomitantní chemoradioterapie s konsolidační imunoterapií? Posoudit resekabilitu, funkční operabilitu a výběr platinového derivátu při sníženém eGFR.

NOMINACE

Typ projednání: primární projednání. Požadované zaměření MDT: plicní a hrudní onkologie. Navrhující odbornost: pneumologie. Předpokládaný záměr léčby: kurativní.